DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MARIA RITA VELASCO DELGADO **Identificación** CC 29371007
Edad: 89 AÑOS **Empresa:** SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. SUBSIDIADO-2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	Y85	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K294 GASTRITIS CRONICA ATROFICA

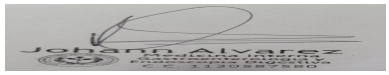
Dx Postoperatorio: K253 ULCERA GASTRICA AGUDA SIN HEMORRAGIA NI PERFORACION

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 12:55:00 **Hora Final** 13:05:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: HVDA
ESOFAGO: Normal hasta tercio distal. Hernia hiatal de aprox 3 cm con mucosa herniaria normal.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico normales. Mucosa corporoantral adelgazada con visualización de trama vascular. En antro hacia curvatura mayor se observó úlcera excavada de bordes elevados de aprox 25mm de diametro mayor, cubierta de fibrina no se observa sangrado activo ni reciente. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
***CONCLUSION:
1. HERNIA HIATAL
2. GASTRITIS CORPOROANTRAL ATRÓFICA MODERADA
3. ÚLCERA DE ANTRO FORREST III

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***